

14 - 04- Les Pancréatites Chroniques - Pr. Samlani

Les pancréatites chroniques La pancréatite chronique se caractérise par des lésions inflammatoires chroniques du pancréas associant une destruction progressive du parenchyme exocrine et endocrine avec formation de concrétions protéiques qui vont secondairement se classer. Ce sont des petites boules de protéines qui vont boucher les canaux et qui vont se classer. Elles se caractérisent aussi par des anomalies canalaire avec alternance de sténose et de dilatation du canal principal et des canaux secondaires.

La cause principale à la pancréatite chronique est l'alcool et le diagnostic positif repose en grande partie sur l'imagerie. Dans les conditions physiologiques, le suc pancréatique est une solution saturée de calcium, de lipase, d'amylase et de pepsine. Il existe des enzymes, la citrate qui chélate le calcium, ça veut dire le détruit, empêche sa précipitation et la lithostatine qui inhibe la formation de cristaux de carbonate de calcium.

L'action de ces deux éléments empêche la précipitation et la formation des concrétions protéiques dont on a parlé. L'alcool va agir sur différents points. D'abord au niveau du suc pancréatique, le rendant plus épais.

Ensuite, l'alcool va inhiber l'action de la citrate, ce qui va favoriser la précipitation du calcium. Elle va inhiber l'action de la lithostatine et cette double action va entraîner un suc pancréatique qui est plus épais et qui est plus apte à se déposer avec la formation de cristaux de calcium et la formation de concrétions protéiques. Parallèlement, l'alcool a une toxicité directe au niveau du parenchyme pancréatique.

Sur cette diapositive, vous avez le processus de la lithogénèse pancréatique, la lésion initiale et la précipitation protéique dans les canaux. Ces précipités protéino-calcaïques vont se déposer et il y aura des lésions inflammatoires, puis des lésions canalaire, puis l'évolution vers la fibrose. La destruction du parenchyme et la fibrose seront responsables d'une insuffisance de sécrétion pancréatique, donc d'une insuffisance pancréatique.

D'abord, exocrine, ce qui va se manifester par une diarrhée chronique, par une stéatorée. Puis endocrine, ce qui se manifestera par un diabète. Les complications au cours de la pancréatite chronique dépendent du stade.

Au tout début, les poussées aiguës sont les plus fréquentes. Elles vont se manifester par des épisodes douloureux et des complications à type de kystes, des pseudokystes. Les kystes rétentionnels résultent de la mise sous pression des canaux pancréatiques avec une distension secondaire.

Les pseudokystes, quant à eux, sont des formations qui n'ont pas de paroi propre, qui résultent d'une poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique et qui correspondent à la résorption de la nécrose, qui est généralement extrême pancréatique, et qui peuvent se

compliquer d'une compression de la voie biliaire principale, être responsable dans ce cas-là d'amyctère, d'une compression du d'nal, être responsable de vomissement, d'une compression et d'érosion vasculaire, être responsable d'hémorragie digestive ou même d'hypertension portale. Comme ces pseudokystes peuvent très bien s'ouvrir, entraîner des fistules pancréatiques, dans la plèvre et ne se manifester pas une pleurésie, ou bien dans l'abdomen, ne se manifester pas une acide. Donc les pseudokystes sont des collections liquidiennes qui sont organisées, intra- ou extra-pancréatiques, comme on a dit, qui contiennent du sucre pancréatique pur ou bien de la nécrose, qui n'ont pas d'épithélium propre et qui sont limitées par une paroi fibreuse ou granuleuse.

Ils sont responsables, quand ils compriment les organes de voisinage, de beaucoup de symptômes. Quand ils compriment la voie biliaire principale, ils peuvent donner amyctère. Quand ils compriment le thudénom, ils peuvent donner un syndrome de sténose.

Et quand ils compriment des vaisseaux, ils peuvent se compliquer d'hypertension portale. Ils peuvent même entraîner ou simuler une occlusion lorsqu'il y a une compression du colon. Enfin, ils peuvent se rompre, entraîner ce qu'on a appelé des fistules, dans des organes creux, dans la plèvre, dans l'abdomen, ou même entraîner un tableau d'hémorragie intra-kystique quand il y a une érosion intra-kystique.

Ils peuvent également être responsables d'un sepsis, lorsqu'il y a une infection importante, qui peut nécessiter une antibiotérapie avec drainage. Et ils peuvent également être responsables de ce qu'on appelle le syndrome de Weber-Christian, la cytotéatonécrose, c'est-à-dire une nécrose de la graisse sous-cutanée, avec une fièvre et des nodules vermo-hypodermiques inflammatoires, voire même une polyarthrite, lorsque le contenu de ces pseudokistes diffuse sous la peau. Alors quelles sont les étiologies de la pancréatite chronique ? Il y a tout d'abord la pancréatite chronique alcoolique, qui est la plus fréquente.

L'alcool est une cause nécessaire mais non suffisante, c'est-à-dire que l'alcool est nécessaire pour la jeunesse d'une pancréatite chronique, mais toute personne qui consomme de l'alcool ne fera pas nécessairement une pancréatite chronique. Des cofacteurs environnementaux et génétiques interviennent aussi. Les mécanismes toxiques l'acnol sont multiples, c'est ce que je vous ai montré en physiopathologie.

Il augmente la concentration protéique et la viscosité du sucre, ce qui donnera à ce sucre plus de propension à former des bouchons protéiques. Il a également une toxicité directe sur les cellules pancréatiques, avec une activation précoce des enzymes. Il y a ensuite les pancréatites chroniques non alcooliques.

Parmi celles-ci, les causes toxiques et métaboliques, au cours de l'hypercalcémie chronique, au cours d'une hyperparathyroïdie, le dépôt de calcium va bien sûr entraîner des sténoses au niveau des canaux pancréatiques et va entraîner bien sûr, par les mêmes mécanismes, une dilatation de

ces canaux, une suffusion du sucre pancréatique et des lésions inflammatoires qui vont à la longue entraîner de la fibrose. Les causes génétiques, les pancréatites héréditaires, représentent 1% des pancréatites chroniques. On les suspecte devant la jeûne et l'histoire familiale, quand il y a des antécédents dans la famille.

Trois gènes sont responsables. Le premier, c'est le gène PRSS1 muté, qui est responsable de 50 à 80% des pancréatites génétiques. La transmission se fait sous un mode autosomal dominant, associé à un sur-risque d'adénocarcinome du pancréas, et la prévention va reposer sur le sevrage du tabac et de l'alcool.

Les deux autres, on a bien sûr la mutation du gène SPINK1, PSPI, et on a la mutation du gène CFTR, qui est responsable de la mucoviscidose. Autre étiologie que vous devez connaître, c'est la pancréatite auto-immune. C'est une condition qui est relativement rare, mais qu'on voit de plus en plus.

Elle a la particularité d'être à nette prédominance masculine, par opposition aux autres pathologies auto-immunes. Elle reconnaît deux formes. Une forme diffuse et une forme dite pseudo-tumorale, ça veut dire qui mime une tumeur du pancréas.

Et cette condition peut être associée à des marqueurs biologiques d'auto-immunité positive. Elle peut également être associée à des maladies auto-immunes, notamment des maladies inflammatoires chroniques intestinales, une cholangite clérosante primitive, ou bien un diabète de type A. On citera enfin les autres étiologies de pancréatite chronique, les pancréatites aïe aux endophiles, les pancréatites radiques suite à une radiothérapie, dans les suites à long terme, les étiologies obstructives quand il y a des obstacles tumoraux sur les canaux pancréatiques, et ce qu'on appelle les causes idiopathiques dont on ne reconnaît pas de cause et qui représentent 10% de l'ensemble des pancréatites chroniques. L'histoire naturelle de la pancréatite chronique évolue sur plusieurs années.

La première période, après cinq ans depuis le début de la maladie, se manifestera par des poussées aiguës qui sont fréquentes. Survient ensuite la deuxième période entre cinq et dix ans. Les douleurs et les poussées diminuent, le risque de complications augmente avec le temps, à type de pseudokystes de compression.

Ensuite la troisième période, au-delà de dix ans, où les douleurs se font de plus en plus rares parce que la fibrose est plus importante, où le patient va surtout souffrir des complications de sa pancréatite, l'insuffisance pancréatique exocrine et endocrine. De cette histoire naturelle découle l'étude clinique. Les signes fonctionnels que l'on retrouve, ce sont souvent la douleur abdominale.

La douleur abdominale est caractéristique, c'est ce qu'on appelle le syndrome pancréatico-solaire de Chauffard. Elle est de siège épigastrique-susombilical. À irradiation postérieure, on dit qu'elle est transfixiante, qu'elle transperce le ventre.

Elle peut demander au patient ou imposer une position antalgique, qui est celle en antéflexion, recroquevillée sur lui-même en chien de fusil. Elle est déclenchée souvent par des repas copieux ou par la prise d'alcool, calmée par les anti-inflammatoires et de durée variable. On peut retrouver d'autres signes, un amégrissement variable, une diarrhée graisseuse, un diabète d'apparition récente, un nyctère occasionné par une compression ou d'autres signes tels une fièvre, des troubles respiratoires.

L'examen physique peut être normal, comme il peut refléter des complications, une sensibilité épigastrique, une dénutrition ou un amégrissement. Alors quels sont les examens paracliniques à réaliser ? L'imagerie a une place importante dans la pancréatite chronique. L'examen clé est la thomocénsitométrie abdominale, le scanner, qui étudie le paranchyme, sa taille et son aspect, qui recherche la présence de calcifications, qui recherche également la dilatation des canaux pancréatiques et leurs sténoses, ce qu'on appelle les dilatations irrégulières, et qui peut retrouver des complications telles que les pseudokistes.

Cette imagerie est souvent précédée par une échographie abdominale, qui peut retrouver des calcifications avec des condombres postérieurs et des pseudokistes. C'est un examen qui a la particularité d'être souvent disponible, qui est peu coûteux et qui peut être un excellent examen de débrouillage avant donc d'indiquer des examens plus poussés. Enfin, l'IRM pancréatique est le meilleur examen pour l'étude des anomalies canalaères.

Elle est supérieure à la TDM pour les formes débutantes, pour cette même raison qu'elle étudie très bien les anomalies canalaères qui sont précoces, elle a l'avantage de pâtre irradiante, n'utilise pas de produits de contraste toxique. Enfin l'endoscopie. D'abord l'échoendoscopie, qui est un examen qui permet de faire une étude du paranchyme pancréatique et des canaux pancréatiques de manière très fiable par vent endoscopique, qui permet surtout de réaliser un geste diagnostique par biopsie ou un geste thérapeutique par drainage de pseudokites, mais qui a la particularité d'être opérateur dépendant.

La CPRE ou cathéterisme rétrograde pérandoscopique était jadis avant utilisée pour l'étude canalaère. C'est un geste qui est invasif, qui se fait sous endoscopie avec cathéterisme de la voie biliaire ou des canaux pancréatiques. Actuellement il est réservé pour les gestes thérapeutiques, il n'est plus utilisé pour une indication diagnostique.

La biologie, enfin. Elle a un intérêt en poussée, surtout par l'hypasémie la CRP pour poser le diagnostic de pancréatite écueille. Elle peut avoir un intérêt pour l'évaluation de la fonction pancréatique par la réalisation des tests fonctionnels que vous avez vus en physiologie, qui sont la stéatorée, le PABATest, ou bien par le dosage de l'élastase fécale, qui est un examen qui est très utile pour l'évaluation de la suffisance pancréatique exocrine.

Quelle est la démarche diagnostique à utiliser ou bien adopter pour le diagnostic du pancréatite chronique ? Il faut savoir que le diagnostic repose souvent sur un faisceau d'arguments plus une

échographie ou une endocytométrie qui montrent des choses en faveur d'une pancréatite chronique. Ensuite les autres examens, que ce soit l'IRM ou l'endoscopie, seront réalisés en deuxième intention. Le diagnostic différentiel se fera au stade de douleur avec les urgences l'ulcér-gastro-adrénaline, la cholecystite aiguë, la pancréatite aiguë en dehors d'une pancréatite chronique et l'infarctus mésentérique.

Après réalisation des examens radiologiques, notamment l'examen le plus simple qui est l'échographie, on peut penser à un cancer pancréatique, on peut penser à des tumeurs, intracanalères, notamment des tumeurs qu'on appelle les tumeurs intracanalères papillaires et mucineuses. Les formes cliniques sont variables. On peut retrouver une pancréatite chronique révélée au tout début par des poussées de pancréatite aiguë, comme on peut trouver des patients au stade de forme très tardive.

Il y a également des formes de pancréatite chronique sur obstruction lorsqu'il y a une tumeur intracanalère qui obstrue et qui évolue insidieusement vers une pancréatite chronique. On peut avoir également des patients diagnostiqués au stade de complications et ces complications sont les pseudokistes, l'hémorragie digestive, les fistules, les ictères rétentionnelles, les épanchements, des lésions spléniques quand il y a une diffusion de coulées de nécrose ou bien de sucs pancréatiques, la nécrose graisseuse ou cutanée avec parfois une atteinte ostéo-articulaire et à des stades très évolués, les pancréatites chroniques peuvent se compliquer de dégénérescence de cancer. Le traitement.

Le but du traitement est de traiter la douleur, donc la crise douloureuse, d'éviter les survenues de complications, de traiter ces complications si elles sont déjà survenues et bien sûr de corriger les insuffisances, notamment l'insuffisance pancréatique exocrine et l'insuffisance pancréatique endocrine. Les moyens dont on dispose sont des moyens hygiénothétiques. D'abord le sevrage alcoolique.

Il faut brancher le patient dans une consultation d'addictologie et favoriser ce sevrage. Les extraits pancréatiques tels que le robiol et le créon qui vont supplanter la sécrétion pancréatique exocrine. L'insuline bien sûr au stade de diabète.

Des traitements abutantalgiques, tels que le paracétamol et les dérivés morphiniques. Des traitements chirurgicaux et des traitements endoscopiques. Les indications sont en fonction du stade.

En cas de poussée, en cas de complications ou en cas d'insuffisance pancréatique exocrine. En cas de poussée, bien sûr, ça sera surtout les antidouleurs. En cas de complications, les drainages endoscopiques ou chirurgicaux.

Et en cas d'insuffisance pancréatique exocrine, les suppléments. Les résultats dépendront de la précocité de la prise en charge. Dépendront aussi des autres complications liées à l'alcool et des lésions associées.

En conclusion, il s'agit d'une destruction progressive et irréversible du parenchyme exocrine et endocrine, des biologies multiples, à l'histoire naturelle lente, dont le diagnostic est clinique biologique et radiologique et qui impose une prise en charge précoce avec traitement des biologies et des complications.